

Informačný leták pre pacienta: Nadúvanie brucha

1. Čo je to nadúvanie?

Nadúvanie (meteorizmus, abdominálna distenzia) je subjektívny pocit plnosti, tlaku, „napätia“ alebo zväčšenia objemu brucha. Môže byť sprevádzaný aj objektívnym zväčšením obvodu brucha.

Hlavné prejavy:

- Pocit plnosti a ťažoby v bruchu
 - Škvrkanie v bruchu (borborygmy)
 - Grganie a plynatosť
 - Nepříjemné pocity alebo bolesť rôznej intenzity
 - Zmena tvaru brucha
 - Poruchy stolice (zápcha, hnačka, nestabilná stolica)
 - Nevoľnosť, znížená chuť do jedla
-

2. Mechanizmy vzniku nadúvania

- Nadmerná tvorba plynov v črevách
 - Porucha odchodu plynov z tráviaceho traktu
 - Zvýšená citlivosť črevných receptorov
 - Porucha črevnej motility
 - Nerovnováha črevnej mikróflóry
-

3. Príčiny nadúvania

3.1 Alimentárne faktory (strava)

Plynotvorné potraviny:

- Strukoviny (hrach, fazuľa, šošovica, cícer)
- Kapustovitá zelenina (kapusta, brokolica, karfiol)
- Cibuľa, cesnak, artičoky
- Jablká, hrušky, broskyne (vysoký obsah fruktózy)
- Mliečne výrobky (pri intolerancii laktózy)
- Celozrnné produkty
- Sýtené nápoje
- Umelé sladidlá (sorbitol, xylitol)

Nevhodné stravovacie návyky:

- Rýchle jedenie a prehĺtanie vzduchu
- Rozprávanie počas jedla
- Prejedanie sa, nepravidelné jedenie
- Žuvanie žuvačky, pitie slamkou

3.2 Funkčné poruchy

- Syndróm dráždivého čreva (IBS)
- Funkčná dyspepsia, funkčné nadúvanie, funkčná zápcha
- Dysbióza črevnej mikrobioty

3.3 Organické ochorenia

- Zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída)
- Celiakia (intolerancia lepku)
- Chronická pankreatitída
- Cholecystitída, žlčové kamene
- GERD, vredová choroba žalúdka a dvanástnika

3.4 Infekčné príčiny

- Infekcia *Helicobacter pylori*
- Syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO)
- Parazitárne a črevné infekcie

3.5 Hormonálne faktory

- Predmenštruačný syndróm, menopauza, tehotenstvo
- Ochorenia štítnej žľazy (hypotyreóza)
- Cukrovka

3.6 Psychosomatické faktory

- Chronický stres, úzkosť, depresia
- Somatoformné poruchy

3.7 Lieky

- Antibiotiká (dysbióza)
 - NSAID, opioidy, antidepresíva, železo
-

4. Samoobservačný algoritmus a úvodné opatrenia

4.1 Vedenie potravinového denníka

Zaznamenávajúte si denne:

- Čas, zloženie, množstvo a spôsob prípravy jedla
- Kedy sa objavilo nadúvanie, jeho intenzitu (škála 1–10)
- Sprievodné príznaky, stres, fyzickú aktivitu
- Charakter stolice

4.2 Diétne odporúčania

Okamžité obmedzenia:

- Sýtené nápoje, žuvačky, pitie slamkou
- Umelé sladidlá, mastné a pikantné jedlá, veľké porcie

Eliminačná diéta:

1. týždeň – vylúčiť mliečne výrobky
2. týždeň – odstrániť lepok
3. týždeň – vylúčiť strukoviny a kapustu
4. týždeň – obmedziť fruktózu

Odporúčané potraviny:

- Kaše (ryža, pohánka, ovsené vločky)
- Banány, citrusy, mrkva, cuketa, tekvica
- Chudé mäso, ryby, zelené bylinky (kôpor, petržlen), zázvor, mäta
- Kyslomliečne produkty (pri tolerancii)

4.3 Pravidlá stravovania

- Jedzte pomaly, dôkladne prežúvajte
- Nerozprávajte sa pri jedle
- Malé porcie 4–5× denne
- Neľahajte si hneď po jedle, vyhýbajte sa veľmi horúcim alebo studeným jedlám
- Pite vodu medzi jedlami

4.4 Riešenie stresu

- Pravidelný spánok (7–8 hod.)
- Dychové cvičenia, meditácia, joga

- Mierna fyzická aktivita, oddych

4.5 Fyzická aktivita

- Prechádzky 30–40 min denne
 - Cvičenia na brušné svaly, masáž brucha v smere hodinových ručičiek
 - Špeciálne jogové pozície na podporu trávenia
-

5. Varovné príznaky („červené vlajky“)

5.1 Okamžité vyhľadanie lekára:

- Ostrá, intenzívna bolesť
- Krv v stolici, zvracanie krvi
- Teplota nad 38 °C
- Príznaky črevnej nepriechodnosti, žltacka

5.2 Plánovaná návšteva lekára:

- Trvalé alebo zhoršujúce sa nadúvanie
 - Úbytok hmotnosti > 5 % za 6 mesiacov
 - Zmeny stolice, nočné príznaky
 - Rodinná anamnéza GIT ochorení, vek nad 50 rokov
 - Nejasná anémia
-

6. Diagnostický algoritmus

6.1 Základné laboratórne testy:

- Krvný obraz s diferenciálom, pečeňové testy, amyláza, lipáza
- Okultné krvácanie v stolici, koprologia, vajíčka parazitov a prvoky

6.2 Špecifické testy:

- Protilátky proti H. pylori (IgG, IgA)
- Dýchacie testy (laktulóza – SIBO, laktóza)
- Protilátky pri celiakii (gliadín, tTg)
- Kalprotektín v stolici

6.3 Inštrumentálne vyšetrenia:

- USG brucha
- EGDS, kolonoskopia (podľa indikácie)
- Röntgen, CT/MRI podľa potreby

6.4 Ďalšie vyšetrenia:

- Manometria pažeráka, pH-metria, GIT scintigrafia

V prípade, že sa rozhodnete konzultovať váš stav so mnou, odpovedzte, prosím, na nasledujúce otázky:

Primárna diagnostika meteorizmu

1. Charakteristika nadúvania:

1. Ako dlho po jedle sa objavuje nadúvanie (hneď, po hodine...)?
2. V ktorú dennú dobu sa najčastejšie objavuje (ráno, popoludní, večer)?
3. Ako často sa objavuje (denne, niekoľkokrát týždenne, občasne)?
4. Ako dlho trvá?
5. Je prítomná bolesť brucha? Kde a aká je – ostrá, tupá, pichľavá?
6. Máte škvŕkanie, pocit prelievania, nevoľnosť alebo grganie?
7. Mení sa nadúvanie podľa polohy tela (sedenie, státie, ľah)?
8. Zhoršuje sa alebo zlepšuje nadúvanie pri pohybe?

2. Výživové a behaviorálne faktory:

9. Existujú potraviny, ktoré určite nespôsobujú nadúvanie?
10. Všimli ste si intoleranciu na laktózu, lepok, strukoviny alebo kapustu?
11. Ako často konzumujete pikantné, mastné, vyprážané jedlá, fastfood?
12. Jete rýchlo, rozprávate pri jedle, prehltáte veľa vzduchu (aerofágia)?
13. Jete potichu a sústredene?
14. Skúšali ste si viesť potravinový denník a sledovať reakcie tela?

3. Funkcie tráviaceho traktu:

15. Máte zápchu, hnačku, hlien alebo krv v stolici?
16. Došlo k prudkému úbytku hmotnosti?
17. Užívate alebo ste nedávno užívali antibiotiká?

4. Psycho-emocionálny a celkový stav:

- 18. Ste v strese, prežívate úzkosť alebo emočné vyčerpanie?
- 19. Aký máte režim spánku a fyzickej aktivity?

5. Zdravotná anamnéza:

- 20. Absolvovali ste vyšetrenia na H. pylori, gastritídu, IBS?
- 21. Podstúpili ste vyšetrenia u gastroenterológa (EGDS, kolonoskopia)?
- 22. Máte varovné príznaky – nočné bolesti, anémiu, extrémnu únavu, rodinnú anamnézu rakoviny GIT?

6. Gynekológia (u žien):

- 23. Má nadúvanie súvislosť s menštruačným cyklom?
- 24. Máte gynekologické ochorenia (napr. endometriózu)?

Dr. Erkin